



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Data de Emissão	Data de Aprovação	Data da Vigência	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
18/11/2020	18/11/2020	18/11/2022	18/11/2022	nº 01	01	01 a 10

Nome do procedimento – REGISTRO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL

Área: Todos os pontos da Atenção Primária à Saúde. **Sector:** Secretaria Municipal da Saúde.

Executantes: Profissionais de Nível Superior.

Objetivo: Padronizar a forma de registro eletrônico ao Atendimento Individual.

Recursos necessários:

- Prontuário eletrônico;
- Para este tipo de registro, o paciente deve ter sido avaliado presencialmente pelo profissional de saúde na data do registro;
- Caso no momento do atendimento haja alguma falha de conexão de internet ou falta de luz que impeça o registro no prontuário naquele momento do atendimento, anotar o atendimento em instrumento físico de evolução (papel) ou arquivo digital e transcrever o atendimento para o prontuário eletrônico assim que possível, na data e horário que foi realizado o atendimento.

Conceito: Consiste no registro das informações de atendimentos individuais realizados por profissionais de nível superior na Atenção Primária.

Profissionais que utilizam o registro de Atendimento Individual: É utilizada por profissionais de nível superior das equipes de Atenção Primária, do Núcleo de Ampliado de Saúde da Família (NASF), do Consultório na Rua (eCR) e das equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP), com exceção do cirurgião-dentista, que preenche a Ficha de Atendimento Odontológico Individual (específica para ESB).

Descrição:

1. Verificar os dados do paciente: Ao abrir o Atendimento Individual, verificar se corresponde ao paciente correto, através da verificação do nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Verificar se o Cartão Nacional do SUS e CPF estão devidamente preenchidos. É importante que todos os cidadãos do território adscrito tenham o número do CNS e CPF, mesmo que este item não seja de preenchimento obrigatório. Esse número é essencial para a identificação e vinculação do cidadão. Caso o número não seja preenchido, não será possível visualizar informações identificadas nos relatórios de saúde do Ministério da Saúde.

2. Preencher dados da Pré-Consulta/Aferições: Neste campo, conforme **Figura 1**, poderão ser preenchidos dados como peso (kg), estatura (cm), circunferência abdominal (cm), temperatura (°C), pressão arterial (mmHg), frequência cardíaca (bpm), nível de glicemia capilar (mg/Dl), vacinação em dia (ao clicar em “caderneta”, é possível verificar a caderneta de vacina do usuário), frequência respiratória e saturação de oximetria (%). Neste momento, já poderão ser adicionados os códigos destes procedimentos realizados.

Figura 1 - Pré-consulta:

Aferições			
Peso*	0,000	Estatura*	0,0 cm
	Kg		
Temperatura		Pressão	/ mmHg
	°C		
Nível de Glicemia		Tipo de Glicemia	Selecione...
	mg/Dl		
Vacinação em Dia*	Selecione...	Caderneta	
Condição	(Informe dados importantes p/ conhecimento do Médico.)		
Frequência Respiratória		Saturação de Oximetria	%
Procedimentos Realizados			
0301100039 - Afericao De Pressao Arterial			☐
0301100250 - Afericao De Temperatura			☐
0214010015 - Glicemia Capilar			☐
0101040075 - Medicao De Altura			☐
0101040083 - Medicao De Peso			☐
Marque os Procedimentos Realizados.			
Local de Atendimento: 01 - Ubs			

2.1 Ocorrências em saúde: Poderão ser anotados neste campo ocorrências imprevistas, indesejáveis ou potencialmente perigosa na instituição de saúde, como por exemplo: “Usuário agressivo em atendimento”. Neste campo não deverão ser anotadas informações acerca do estado de saúde do paciente. Estes dados poderão ser visualizados por qualquer integrante da equipe, como por exemplo Agente Administrativo e Agente Comunitário de Saúde.

2.2 Resultados de exames: Neste campo, poderão ser visualizados os resultados de exames anteriores registrados no prontuário do usuário.

2.3 Consumo Alimentar: Poderão ser anotados neste campo, que localiza-se na parte superior do prontuário eletrônico conforme **Figura 2**, dados referentes ao consumo alimentar do usuário conforme a idade que está dividida em lactentes até 6 meses de idade, de 6 meses de idade até 2 anos e acima de 2 anos onde são os mesmos questionamentos para adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Estes dados podem ser úteis para a realização da avaliação nutricional e orientações de correção alimentar.

Figura 2 - Consumo alimentar:

Crianças com 2 anos ou mais, adolescentes, adultos, gestantes e idosos

Você tem costume de realizar as refeições assistindo à TV, mexendo no computador e / ou celular ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe

Quais refeições você faz ao longo do dia? ☐ Café da manhã ☐ Lanche da manhã ☐ Almoço ☐ Lanche da tarde ☐ Jantar ☐ Ceia

Ontem você consumiu:

Feijão ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe

Frutas frescas (não considerar suco de frutas) ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe

Verduras e / ou legumes (não considerar batata, mandioca, aipim, macaxeira, cará e inhame) ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe

Hambúrguer e / ou embutidos (presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha) ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe

Bebidas adoçadas (refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco de caixinha, xaropes de guaraná / groselha ou suco de fruta com adição de açúcar) ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe

Macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe

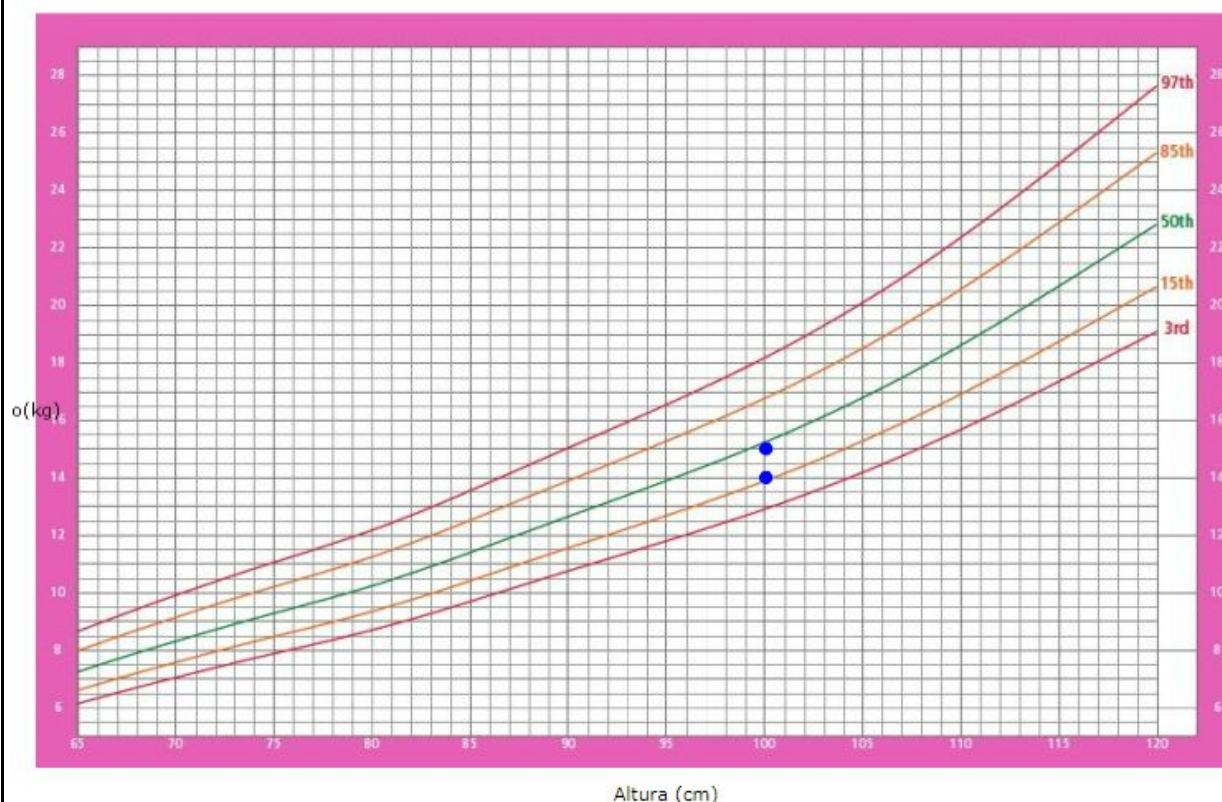
Biscoito recheado, doces ou guloseimas (balas, pirulitos, chiclete, caramelo, gelatina) ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe

 Gravar

3. Atendimento Compartilhado: Visa um atendimento integrado, multidisciplinar e compartilhado, atendendo as necessidades de cada usuário, onde cada profissional de diferentes categorias ofertam a sua conduta dentro de cada núcleo do saber, de forma a complementar em um objetivo comum. O registro de atendimento compartilhado, não deve ser utilizado para registrar outros atendimentos individuais realizado por apenas um dos profissionais, por exemplo caso o enfermeiro da equipe compartilhe o atendimento com o profissional médico e nesta avaliação seja necessária alguma requisição de exame exclusiva do médico ou prescrição médica, o profissional médico deverá abrir um atendimento individual para registrar suas condutas específicas e privativas de sua categoria profissional.

4. Dados clínicos permanentes: Neste campo, poderão ser anotadas informações permanentes a respeito do histórico de saúde do usuário, por exemplo histórico de cirurgias, doenças crônicas, situações de vulnerabilidade. Toda vez em que o prontuário eletrônico for aberto por qualquer profissional de nível superior ou técnico da equipe, estes dados serão visualizados. Os dados poderão ser apagados quando for necessário.

5. Índices/Gráficos: Neste ferramenta, poderão ser visualizadas as curvas de crescimento e desenvolvimento, como: perímetro cefálico, curva de crescimento (peso/altura - **Figura 3**; peso/idade; altura/idade; IMC/Idade com a respectiva classificação da situação nutricional) e gráficos contendo o histórico de aferições de glicemia capilar e pressão arterial. Os dados que alimentam estes índices/gráficos são os anotados no item “Pré- Consulta”.

Figura 3 - Curva de crescimento peso/altura:

6. Avaliação de Exames: É por esta tela que se inserem os resultados e as avaliações de exames trazidos pelo usuário. Estas avaliações, além de constarem no prontuário, também são exportadas ao E-SUS na seção de exames avaliados, importante informação para a composição dos indicadores do Programa Previnde Brasil.

7. Evolução Profissional: Na Atenção Primária do Município, padroniza-se a utilização da evolução profissional por meio da metodologia “SOAP”, conforme **Quadro 1:**

Quadro 01 - Método SOAP:

“Subjetivo”(S)	Nessa parte se anotam as informações recolhidas na entrevista clínica sobre o motivo da consulta ou o problema de saúde em questão. Inclui as impressões subjetivas do profissional de saúde e as expressadas pela pessoa que está sendo cuidada.
“Objetivo”(O)	Nessa parte se anotam os dados positivos (e negativos que se configurarem importantes) do exame físico e dos exames complementares, incluindo os laboratoriais disponíveis.
“Avaliação”(A)	Após a coleta e o registro organizado dos dados e informações subjetivas (S) e objetivas (O), o profissional de saúde faz uma avaliação (A) mais precisa em relação ao problema, queixa ou necessidade de saúde, definindo-o e denominando-o. Nessa parte se poderá utilizar, se for o caso, algum sistema de classificação de problemas clínicos, por exemplo a Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) ou CID-10.

“Plano”(P)

A parte final da nota de evolução SOAP é o plano (P) de cuidados ou condutas que serão tomados em relação ao problema ou necessidade avaliada. De maneira geral, podem existir quatro tipos principais de planos:

- 1) Planos Diagnósticos: nos quais se planejam as provas diagnósticas necessárias para elucidação do problema, se for o caso;
- 2) Planos Terapêuticos: nos quais se registram as indicações terapêuticas planejadas para a resolução ou manejo do problema da pessoa: medicamentos, dietas, mudanças de hábitos, entre outras;
- 3) Planos de Seguimento: nos quais se expõem as estratégias de seguimento longitudinal e continuado da pessoa e do problema em questão;
- 4) Planos de Educação em Saúde: nos quais se registram brevemente as informações e orientações apresentadas e negociadas com a pessoa, em relação ao problema em questão.

Atenção: Poderão ser criados modelos de evolução ou utilizados os modelos padronizados pelo município, como por exemplo os modelos de evolução para atendimentos ao adulto na demanda espontânea pelos Enfermeiros, disponível em: bit.ly/modelosevolucaoenf.

8. Evolução Confidencial: Campo destinado ao registro da evolução confidencial do usuário. Ao registrar evolução neste campo, o profissional poderá optar em deixar as informações ali registradas visíveis somente para si próprio ou para a categoria profissional a qual pertence. Neste caso, a visibilidade em prontuário das informações ali registradas irá respeitar a opção assinalada no momento do registro. Campo não transmitido ao E-SUS.

9. Códigos de Procedimentos: Utilizar obrigatoriamente pelo menos 1 código de procedimento. Deverão ser utilizados quantos códigos forem preciso, de acordo com todos os procedimentos que foram realizados durante a consulta. Consultar os códigos de procedimento por categoria profissional de acordo com o **SEI n. 20.0.171252-3**.

10. CID ou CIAP: Utilizar pelo menos 1 dos seguintes códigos:

10.1 CIAP-2 – Para ser utilizado por profissionais de nível superior. O sistema CIAP-2 é uma ferramenta adequada à Atenção Primária que permite classificar questões relacionadas às pessoas e não a doenças. Poderão ser adicionados até dois códigos para registrar problemas identificados usando a Classificação Internacional de Atenção Primária, versão 2. **Conheça a relação completa do CIAP-2 em:** <http://bit.ly/ciap2>.

10.2 CID-10 – Para ser utilizado por profissionais conforme a autorização do Conselho Regional da sua categoria profissional. Poderão ser utilizados quantos CIDs forem necessários para registrar problemas identificados utilizando a Classificação Internacional de Doenças, versão 10.

11. Problema/Condição Avaliada: Neste campo, conforme **Figura 4**, poderão ser preenchidos todos os problemas ou condições do usuário que forem **avaliados ou manejados** pelo profissional durante o atendimento. O campo é de múltipla escolha, permitindo que sejam selecionadas várias opções de acordo com o que foi avaliado no atendimento. Algumas opções serão preenchidas automaticamente de acordo com o procedimento registrado: Puerpério (até 42 dias), quando lançado o procedimento de consulta puerperal; Puericultura, quando lançado o procedimento de avaliação do crescimento na puericultura e/ou avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura ou Pré-natal. Problemas ou condições avaliadas que forem avaliados e não constarem na listagem podem ser preenchidos por meio do CIAP ou CID-10.

Figura 4 - Problema/Condição Avaliada

Problema/Condição Avaliada			
☐ PRE-NATAL	☐ PUERPERIO (ATE 42 DIAS)	Doenças Transmissíveis	Rastreamento
☐ SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA	☐ PUERICULTURA	☐ TUBERCULOSE	☐ CANCER DO COLO DO UTERO
☐ HIPERTENSAO ARTERIAL	☐ DIABETES	☐ HANSENIASE	☐ CANCER DE MAMA
☐ OBESIDADE	☐ DESNUTRICAÇÃO	☐ DENGUE	☐ RISCO CARDIOVASCULAR
☐ ASMA	☐ DPOC	☐ DST	
☐ TABAGISMO	☐ USUARIO DE ALCOOL		
☐ USUARIO DE OUTRAS DROGAS	☐ SAUDE MENTAL		
☐ REABILITACAO			

11.1 Em relação à coluna de “Rastreamento”: Marque a opção que identifique a situação encontrada:

- **Câncer de colo de útero** - Orientação e realização/encaminhamento de exame específico. Se a coleta do exame citopatológico ocorrer na UBS, este deve ser registrado através do código de procedimentos.
- **Câncer de mama** - Orientação e realização de exame clínico de mamas e/ou encaminhamento para realização de mamografia.
- **Risco cardiovascular** - Realização da avaliação de risco pelo escore de Framingham; rastreamento de dislipidemia, hipertensão e diabetes mellitus.

12. Tipo de Atendimento: Marcar 1 das seguintes opções:

12.1 Consulta agendada programada/cuidado continuado: São consultas que constituem ações programáticas individuais, direcionadas para os ciclos de vida, doenças e agravos prioritários, as quais necessitam de acompanhamento contínuo. Como exemplo, o cuidado dispensado às gestantes, crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes), etc.

12.2 Consulta agendada: É toda consulta realizada com agendamento prévio. É oriunda da demanda espontânea ou por agendamento direto na recepção, de caráter não urgente e que não foi atendida no mesmo dia da procura, mas agendada para outro dia. Por exemplo, casos de lesões de pele, sem sinais flogísticos ou infecciosos; queixas inespecíficas de fadiga; cansaço; cefaleia crônica; mudança ou início de medicação anticoncepcional etc.

12.3 Escuta inicial/orientação: Refere-se à escuta realizada por profissional de nível superior no momento em que o usuário chega ao serviço de saúde, relatando queixas ou sinais e sintomas percebidos por ele. Não inclui as orientações de fluxos dentro da UBS. Durante o acolhimento e a escuta, o profissional, quando possível, irá resolver o caso por meio de orientação. Caso contrário, poderá ser realizada a classificação de risco e análise de vulnerabilidade para as devidas providências, por exemplo, encaminhamento para consulta no mesmo dia ou data posterior.

12.4 Consulta no dia: É a consulta que é realizada no mesmo dia em que o usuário busca o serviço, de caráter não urgente. Pode representar também a consulta realizada no dia por haver disponibilidade na agenda do profissional. Como exemplo, quadros com sintomas de dor de grande intensidade ou que não têm indicação de aguardar agendamento para outro dia, como dor lombar, dor na garganta, sintomas urinários etc. Outra indicação de atendimento no mesmo dia pode estar relacionada com a vulnerabilidade social ou psíquica do usuário.

12.5 Atendimento de urgência: (somente para médicos). É o atendimento realizado ao usuário quando há possibilidade de agravamento do quadro ou risco de vida e que determina a necessidade de assistência imediata para alívio do sofrimento físico e/ou psíquico, recuperação do estado de saúde, estabilização/suporte de vida e/ou encaminhamento a outro ponto da rede quando necessário. Como exemplos, casos de dor torácica, sintomas e/ou sinais neurológicos, urgência hipertensiva etc.

13. Local de Atendimento: Informar o local em que foi realizado o atendimento do usuário, considerando as seguintes opções: (01) UBS - Unidade Básica de Saúde; (02) Unidade Móvel; (03) Rua; (04) Domicílio; (05) Escola/Creche; (06) Outros; (07) Polo (academia da saúde); (08) Instituição/Abrigo; (09) Unidade Prisional ou congêneres; (10) Unidade Socioeducativa.

13. Atenção Domiciliar: A modalidade de atenção domiciliar deve ser preenchida nos casos em que se preveja um cuidado continuado no domicílio, e não naqueles casos de atendimentos pontuais. Por exemplo, se o atendimento for a um paciente acamado após um acidente vascular cerebral, o cuidado prestado pela equipe provavelmente será contínuo; com isso, é importante registrar a modalidade de AD de forma a gerar dados para o acompanhamento contínuo. Ao contrário, não é recomendado esse registro, por exemplo, no caso de um atendimento domiciliar pontual a uma pessoa com transtorno afetivo bipolar, que usualmente receba atendimentos na UBS. Atentar para que, em ambas as situações exemplificadas, no campo “Local de atendimento”, deve-se marcar “domicílio”.

13.1 AD1 - Atenção Domiciliar modalidade tipo 1: a prestação da assistência à saúde na modalidade AD1 é de responsabilidade das equipes de Atenção Primária (eSF, NASF), por meio de atendimentos regulares em domicílio. Destina-se a usuários que possuam problemas de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que necessitem de cuidados com frequência e com necessidade de intervenções multiprofissionais.

13.2 AD2 - Atenção Domiciliar modalidade tipo 2: a prestação da assistência à saúde na modalidade AD2 é de responsabilidade dos Serviços de Atenção Domiciliar, por meio das SAD/EMAD. **Esta modalidade não deve ser selecionada pelos profissionais da Atenção Primária.**

13.3 AD3 - Atenção Domiciliar modalidade tipo 3: a prestação da assistência à saúde na modalidade AD2 é de responsabilidade dos Serviços de Atenção Domiciliar, por meio das SAD/EMAD. **Esta modalidade não deve ser selecionada pelos profissionais da Atenção Primária.**

14. Racionalidade em Saúde: Campo destinado para informar quando utilizado algum manejo, durante o atendimento, com base em racionalidades em saúde onde se propõe uma abordagem multiprofissional de cuidado em saúde, incluindo as práticas tradicionais/populares, ancestrais e/ou alternativas. Tipos de racionalidade em saúde: Medicina Tradicional Chinesa; Antroposofia Aplicada à Saúde; Homeopatia, Fitoterapia, Ayurveda, Outra.

15. Concluir Consulta e seguir para a próxima tela.

16. Pedidos: Neste item, poderão ser emitidas Receitas da Farmácia Básica; Requisição de Procedimentos, **Figura 5**; Prescrições livres; Declarações/Atestados.

Figura 5 - Solicitação de exames:

Entenda como funciona a nova solicitação de exames!



Procure os procedimentos através do Nome ou da Cesta de Exames.

Usário SUS: Grupo de Usuários SUS - 11 (36 Anos) - Sexo: Feminino
Profissional: Não Disponível - Medicina Interna/Clinica Geral

Modo de Pesquisa: ☒ Procedimento ☐ Cesta de Exames

Pesquisar: Procedimento:

Procedimentos Disponíveis para Seleção

Procedimento	Quantidade	Status
0202080013 - Antibiograma	1	Disponível (Verde)
0202080145 - Microbiológico A Fresco (Direto), Exame	1	Disponível (Verde)
0202080021 - Antibiograma C/ Concentração Inibitória Mínima	1	Disponível (Verde)
0202080030 - Antibiograma P/ Micobacterias	1	Disponível (Verde)
0202060014 - Atendimento Fisioterapêutico Em Paciente C/ Distúrbios Neuro-Cinético-Funcionais S/ Complicações Sistêmicas	1	Selecionado (Azul)
0202060022 - Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes C/ Distúrbios Neuro-Cinético-Funcionais C/Complicações Sistêmicas	1	Selecionado (Azul)
0201010020 - Biópsia / Puncão De Tumor Superficial Da Pele	1	Disponível (Verde)
0201010099 - Biópsia De Pirâmide Nasal	1	Disponível (Verde)

Procedimentos Selecionados

Procedimento	Quantidade	Status
0302060022 - Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes C/ Distúrbios Neuro-Cinético-Funcionais C/Complicações Sistêmicas	2	Selecionado (Azul)

CID10 Exigido p/ Procedimento:

Depois de escolher todos os procedimentos, quantidades, informar CID e Justificativas, clique em AVANÇAR para seguir para a próxima tela e finalizar seu pedido.

Legendas:

- Procure os procedimentos através do Nome ou da Cesta de Exames.
- Procure aqui o nome do procedimento e clique em **Pesquisar**.
- Clique na Estrela e Marque como favorito os procedimentos solicitados com mais frequência.
- Procedimentos já selecionados neste pedido aparecem em **VERDE**.
- Procedimentos listados em **AZUL**, estão disponíveis para o seu pedido. Para selecionar é só clicar no procedimento desejado.
- Procedimentos desabilitados são mostrados em **CINZA**. Para maiores detalhes clique no ícone de ajuda.
- Se exigir, informe neste local o código CID ou a justificativa para o controle de repetição.
- Altere aqui quantidade solicitada.
- Filtros aplicados na busca aparecem nesta área.
- Todos os procedimentos que possuem o termo da busca aparecem aqui.
- Nesta Área aparecem todos os procedimentos adicionados neste pedido.

*Todas as alterações foram feitas com base nas solicitações de profissionais que utilizam nossa ferramenta.

OLOSTECH

17. Conduta/Desfecho - É utilizado para registrar a conduta/desfecho do atendimento realizado. É obrigatório marcar, pelo menos, uma opção. Selecionar e concluir atendimento:

17.1 Retorno para consulta agendada - Conduta atribuída no momento do atendimento em consulta ou em escuta inicial que demande o agendamento de nova consulta. Não devem ser marcados aqui os retornos que caracteristicamente sejam de cuidado continuado ou programado.

17.2 Retorno para cuidado continuado/programado - Conduta aplicada aos casos em que for necessário o retorno para continuidade do cuidado, como condições crônicas ou de acompanhamento prolongado.

17.3 Agendamento para grupos - Assinalar quando o usuário for orientado a participar de algum grupo terapêutico, de educação em saúde ou de convivência.

17.4 Agendamento para NASF - Campo utilizado para registrar o agendamento do cidadão para os profissionais do NASF.

17.5 Alta do episódio - Utilizado para identificar os atendimentos realizados sem a necessidade de retorno referente ao problema ou condição apresentada.

17.6 Encaminhamento interno no dia - Assinalar quando, após o atendimento, o usuário for encaminhado para atendimento de outro profissional da UBS.

17.7 Encaminhamento para serviço especializado - Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para serviço especializado.

17.8 Encaminhamento para CAPS - Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

17.9 Encaminhamento para internação hospitalar - Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para internação hospitalar.

17.10 Encaminhamento para urgência - Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para atendimento de urgência.

17.11 Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar - Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para o Serviço de Atenção Domiciliar e que não sejam elegíveis para atendimento pela própria Atenção Básica.

17.12 Encaminhamento intersetorial - Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para atendimento em serviços de outros setores, como: Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), escola etc.

18. Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF): Os profissionais do NASF devem utilizar o bloco específico NASF/Polo, conforme **Figura 6**. Este bloco é dividido em três categoriais: prescrição terapêutica; avaliação/diagnóstico e procedimentos clínicos/terapêuticos. Este campo é de preenchimento obrigatório pelos profissionais que atuam no NASF, caso contrário, sua produção não será caracterizada como atendimento NASF.

Figura 6 - Bloco específico para equipe NASF

NASF/Polo: ☐ Prescrição terapêutica ☐ Avaliação / diagnóstico ☐ Procedimentos clínicos / terapêutico

18.1 Prescrição terapêutica - Deve ser marcado sempre que ocorrerem prescrições, orientações e recomendações (prescrições de atividades psicoterapêuticas, recomendações para o usuário – como dietas, exercícios, adaptações no domicílio para atender às demandas relacionadas à funcionalidade e à autonomia, entre outras).

18.2 Avaliação/diagnóstico - Deve ser marcado sempre que forem realizados anamneses, testes e avaliações (testes físicos, inquérito alimentar, avaliação funcional, avaliação psicológica, social, avaliação antropométrica, avaliação psicossocial, entre outros).

18.3 Procedimentos clínicos/terapêuticos - Deve ser marcado sempre que ocorrer intervenção (manipulações osteoarticulares, exercícios respiratórios, estimulações neurosensoriais, exercícios ortoarticulares, exercícios de equilíbrio, psicoterapia, entre outras).

Referências:

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual para preenchimento das fichas de coleta de dados simplificada – cds (versão 3.0), 2018. Disponível em:

<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/esus/Manual_CDS_3_0.pdf>.

Acesso em: 04 nov. 2020.

Elaborado por: Viviane Karina Korovsky	Revisado por: Marisandra Borges Ribeiro Seyboth Gyovana da Rosa Goulart Fernanda Cristina Spiller	Aprovado por: Evaristo Cristobal Iglesias Aleman
Acesso Sistema Eletrônico de Informação - SEI.	Disponível pelo Endereço Eletrônico SEI 20.0.177181-3.	

Alteração após Revisão

Nº	Data	Responsável	Alteração